

Parto instrumentado

1. Introducción y relevancia clínica

El **parto instrumentado** corresponde al **uso de instrumentos obstétricos (fórceps, ventosa o espátulas)** para facilitar la **extracción del feto durante el segundo período del parto**, cuando existen condiciones adecuadas para parto vaginal, pero **el expulsivo no progresa o se requiere acortar su duración** por causa fetal o materna.

El objetivo es **evitar la cesárea innecesaria**, reduciendo los riesgos de hipoxia fetal, trauma perineal o complicaciones maternas.

□ En EUNACOM suelen aparecer preguntas del tipo:

“Gestante en expulsivo prolongado, dilatación completa, cabeza en plano III, FCF 90 lpm → manejo: parto instrumentado (fórceps o ventosa).”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Durante el **segundo período del trabajo de parto**, el feto desciende a través del canal pélvico impulsado por las contracciones uterinas y los pujos maternos.

Cuando este proceso se **interrumpe por fatiga, desproporción o sufrimiento fetal agudo**, puede requerirse **asistencia mecánica** para completar el parto.

El parto instrumentado **reemplaza parcialmente la fuerza expulsiva materna o acorta el expulsivo, nunca sustituye al parto natural en su totalidad.**

3. Indicaciones

A. Maternas

- **Fatiga materna** o agotamiento extremo.
- **Cardiopatía, preeclampsia o enfermedad pulmonar**, donde pujar está contraindicado.
- **Prolongación del expulsivo:**
 - Primípara >2 h (sin analgesia) o >3 h (con epidural).

- Multípara >1 h (sin analgesia) o >2 h (con epidural).

B. Fetales

- **Sufrimiento fetal agudo (bradicardia o desaceleraciones tardías).**
- **Cabeza descendida y parto inminente**, cuando una cesárea demoraría más.

□ La causa más frecuente en Chile es la **prolongación del expulsivo con signos de sufrimiento fetal**.

4. Contraindicaciones

Absolutas

- Feto muerto.
- Desproporción cefalopélvica.
- Presentación no cefálica.
- Cabeza no encajada o desconocida.
- Dilatación cervical incompleta.
- Membranas íntegras.

Relativas

- Coagulopatía materna.
 - Feto <34 semanas (riesgo de hemorragia intracraneal, especialmente con ventosa).
-

5. Requisitos para un parto instrumentado exitoso

1. Dilatación cervical completa.
2. Membranas rotas.

3. Presentación cefálica (occipitoanterior ideal).
4. Cabeza encajada (plano III o IV de Hodge).
5. Posición y orientación fetal conocidas.
6. Ausencia de DCP (pelvis adecuada).
7. Vejiga vacía.
8. Analgesia adecuada (bloqueo peridural o local).
9. Personal entrenado y disponibilidad de cesárea inmediata si falla.

☐ En EUNACOM, cuando el enunciado dice “dilatación completa, membranas rotas, cabeza en plano III, OIA”, se asume que **sí cumple requisitos para parto instrumentado**.

6. Tipos de parto instrumentado

A. Fórceps

Instrumento metálico con dos ramas (cucharas o palas) que se aplican a ambos lados de la cabeza fetal.

Tipos:

- **Fórceps de Simpson:** más común, para cabeza moldeada (parto prolongado).
- **Fórceps de Kielland:** con articulación deslizante, útil para rotaciones.
- **Fórceps de Piper:** usado en parto de nalgas para extracción de cabeza última.

Clasificación según altura de la cabeza:

Tipo	Nivel fetal (plano de Hodge)	Características
Alto	>2 (no encajada)	Prohibido actualmente

Medio	Plano II–III	Rotación leve y descenso parcial
Bajo	Plano III–IV	Cabeza visible en periné
Salida	Cabeza en vulva	Sólo tracción

Indicaciones:

- Expulsivo prolongado.
- Sufrimiento fetal.
- Rotaciones leves o moderadas.

Complicaciones:

- Maternas: desgarros vaginales, perineales o cervicales, hemorragia.
- Fetales: cefalohematoma, equimosis facial, parálisis facial transitoria.

B. Ventosa obstétrica (vacuum extractor)

Instrumento que utiliza **succión** (presión negativa de $-0,6$ a $-0,8$ atm) para adherirse al cuero cabelludo fetal y **traccionar durante las contracciones**.

Tipos:

- **Clásica metálica (Malström).**
- **Descartable de silicona (Kiwi).**

Indicaciones:

- Igual que fórceps, pero preferida cuando se requiere **rotación mínima y menor trauma materno**.

Contraindicaciones:

- Prematurez <34 semanas.
- Presentación de cara o de nalgas.
- Sospecha de coagulopatía fetal.

Ventajas:

- Menor trauma materno.
- Permite cooperación materna (pujos).

Desventajas:

- Mayor tasa de fallo (10–20%).
- Riesgo de cefalohematoma o hemorragia subgaleal.

C. Espátulas (Tarnier o Simples)

Dos palas curvas, no articuladas ni de tracción directa, que **dirigen la salida de la cabeza fetal**.

- Usadas principalmente para **protección perineal** o ayuda final del expulsivo.
- No requieren tracción activa.
- Baja tasa de trauma fetal.

☐ Poco utilizadas actualmente fuera de hospitales docentes o experiencia francesa.

7. Elección del instrumento

Situación clínica	Instrumento ideal
Sufrimiento fetal con cabeza baja	Fórceps

Expulsivo prolongado sin sufrimiento fetal	Ventosa
Necesidad de rotación leve	Fórceps Kielland
Cabeza última en podálica	Fórceps de Piper
Presentación occipitoanterior con periné tenso	Espátulas

8. Técnica básica (resumen)

A. Preparación

- Confirmar criterios de seguridad.
- Explicar procedimiento y obtener consentimiento.
- Asepsia, cateterismo vesical, analgesia adecuada.
- Posición de litotomía.

B. Aplicación

- Introducir el instrumento cuidadosamente siguiendo el eje pélvico.
- Comprobar correcta posición y simetría de las ramas (en fórceps).
- Tracción sincrónica con contracciones y pujos maternos.
- Una vez coronada la cabeza, retirar instrumento suavemente.

C. Control posterior

- Revisar canal del parto (desgarros).
- Evaluar al RN (Apgar, hematomas, parálisis facial).

- Control de sangrado y contracción uterina.

9. Fracaso del parto instrumentado

Definición: imposibilidad de extracción fetal tras tres intentos de tracción o 20 minutos de aplicación.

Conducta:

Suspender procedimiento y realizar **cesárea inmediata**.

10. Complicaciones

Complicación	Tipo	Descripción
Desgarros vaginales o cervicales	Materna	Por aplicación incorrecta
Hemorragia posparto	Materna	Trauma o atonía secundaria
Cefalohematoma o equimosis	Fetal	Compresión capilar
Parálisis facial	Fetal	Lesión del VII par (fórceps)
Hemorragia intracraneal	Fetal	Prematurez + ventosa
Infección	Ambos	Por manipulación prolongada

☐ En EUNACOM suelen preguntar por complicación **más frecuente (cefalohematoma)** y **más grave (hemorragia intracraneal)**.

11. Comparación entre instrumentos

Característica	Fórceps	Ventosa	Espátulas
Tipo de fuerza	Tracción directa	Succión + tracción	Dirección pasiva
Trauma materno	↑	↓	Muy bajo
Trauma fetal	↑	Moderado	Bajo
Rotación	Posible	Limitada	No
Prematurez	Se puede usar	Contraindicado	Se puede usar
Eficacia	Alta	Menor (80–90%)	Auxiliar

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Requisitos obligatorios:** dilatación completa, membranas rotas, presentación cefálica encajada.
2. **Indicaciones principales:** expulsivo prolongado o sufrimiento fetal.
3. **Fórceps de Piper:** para cabeza última en parto de nalgas.
4. **Ventosa:** menor trauma materno, pero más fallas.

5. **Contraindicación absoluta:** presentación alta o no encajada.
6. **Si falla el instrumento** → **cesárea inmediata.**
7. **Cefalohematoma:** complicación fetal más frecuente.



Errores comunes

- Intentar fórceps con dilatación incompleta.
- No identificar posición fetal antes de aplicar.
- Aplicar ventosa en prematuro.
- Traccionar fuera de contracción uterina.
- Intentar parto instrumental con DCP no descartada.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Parto instrumentado:** asistencia mecánica al expulsivo con fórceps, ventosa o espátulas.
2. **Indicaciones:** expulsivo prolongado o sufrimiento fetal.
3. **Requisitos:** dilatación completa, presentación cefálica encajada, pelvis adecuada.
4. **Fórceps:** mayor eficacia, más trauma materno.
5. **Ventosa:** menos trauma materno, contraindicado en <34 s.
6. **Fracaso:** no extracción en 3 intentos o 20 min → cesárea.
7. **Complicación más frecuente:** cefalohematoma; **más grave:** hemorragia intracraneal.